

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Calificación de la Depresión de Hamilton (HDRS / HAM-D)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Calificación de la Depresión de Hamilton
Sigla	HDRS / HAM-D
Autores	Hamilton, M.
Año	1960
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Depresión y anhedonia
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Entrevista heteroaplicada (Clínica)
Disponibilidad en español	Sí (Ramos-Brieva & Cordero-Villafañila, 1986)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Fijar 17/21/24 ítems; no mezclar versiones.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Depresión y anhedonia. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Generalmente unidimensional en uso clínico (gravedad general), pero contiene múltiples agrupaciones de síntomas somáticos, psíquicos y de sueño.

3 Características generales

Formato	Entrevista heteroaplicada (Clínica)
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	17 ítems (versión clásica), también existen de 21 o 24.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Evaluación clínica escalada. Algunos ítems puntúan de 0 a 2, otros de 0 a 4 dependiendo de la gravedad.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Generalmente unidimensional en uso clínico (gravedad general), pero contiene múltiples agrupaciones de síntomas somáticos, psíquicos y de sueño.
Ítems	17 ítems (versión clásica), también existen de 21 o 24.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Evaluación clínica escalada. Algunos ítems puntúan de 0 a 2, otros de 0 a 4 dependiendo de la gravedad.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria de las valoraciones del clínico (Max 52 puntos).

Regla de corrección	Sumatoria de las valoraciones del clínico (Max 52 puntos).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

0-7 (Normal), 8-13 (Leve), 14-18 (Moderada), 19-22 (Severa), ≥23 (Muy severa).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Gold standard en ensayos clínicos de psicofármacos. Sobrerrepresenta síntomas somáticos y de insomnio.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Gold standard en ensayos clínicos de psicofármacos. Sobrerrepresenta síntomas somáticos y de insomnio.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Ramos-Brieva & Cordero-Villafáfila, 1986)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Depresión y anhedonia en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Hamilton, M.; 1960.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Ramos-Brieva & Cordero-Villafáfila, 1986)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Depresión y anhedonia
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 17 ítems (versión clásica), también existen de 21 o 24.; Generalmente unidimensional en uso clínico (gravedad general), pero contiene múltiples agrupaciones de síntomas somáticos, psíquicos y de sueño.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria de las valoraciones del clínico (Max 52 puntos).
Interpretación	0-7 (Normal), 8-13 (Leve), 14-18 (Moderada), 19-22 (Severa), ≥23 (Muy severa).
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Hamilton, M. (1960). Escala de Calificación de la Depresión de Hamilton.

Fuente de referencia del catálogo: Disponible en manuales clínicos.

<https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1967.tb00530.x>

[https://doi.org/10.1016/0022-3956\(88](https://doi.org/10.1016/0022-3956(88)

[https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(03](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(03)

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	HDRS/HAM-D española, forma clínica local de 17 ítems núcleo. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 a662cebe90c51132c9b8c18c45f47e7682c48bb3b698d881ff83511bec1ba59a.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Entrevista clínica heteroaplicada.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	HDRS/HAM-D española, forma clínica local de 17 ítems núcleo.
6. Periodo temporal	Última semana, según la forma local.
7. Escala/formato de respuesta	Ítems con anclajes 0–2 o 0–4; requiere guía clínica.
8. Algoritmo de puntuación	Forma de 17 ítems: sumar los anclajes propios de cada ítem (0–2 o 0–4), rango 0–52. Solo un evaluador entrenado debe asignar las puntuaciones; cortes según manual/estudio elegido.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	0–7 (Normal), 8–13 (Leve), 14–18 (Moderada), 19–22 (Severa), ≥23 (Muy severa). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	NO COMPLETADAS: la nota local identifica posibles autores/titulares, pero en esta revisión no se confirmó una fuente primaria/legítima suficiente de la versión exacta. No fabricar referencias.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.